

39. DESARROLLO DEL ASA INTESTINAL

DURACIÓN : 20:47

FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este vídeo profundiza en el desarrollo embriológico del asa intestinal, haciendo hincapié en la rotación antihoraria del intestino, la importancia de la arteria mesentérica superior y su influencia en la dinámica del crecimiento intestinal. Los conceptos clave abordados incluyen la relación entre el estómago, el hígado y el corazón, así como los diferentes puntos de apoyo esenciales para el desarrollo y funcionamiento del intestino. Además, el vídeo explora los vínculos entre las emociones y la salud intestinal, detallando cómo sentimientos como la ira o el miedo pueden afectar la digestión. También aprenderá la importancia de considerar la dinámica peritoneal al tratar los trastornos intestinales, enriqueciendo así su enfoque terapéutico en osteopatía.

DESARROLLO DEL ASA INTESTINAL

El **cordón umbilical** es inicialmente voluminoso, pero se reducirá a lo largo del desarrollo. Al principio, el **intestino** se desarrolla fuera de la cavidad peritoneal, debido a un importante **aporte trófico**, principalmente proporcionado por la **arteria mesentérica superior**. Esta arteria, que se divide desde la aorta, constituye el eje de la rotación intestinal.

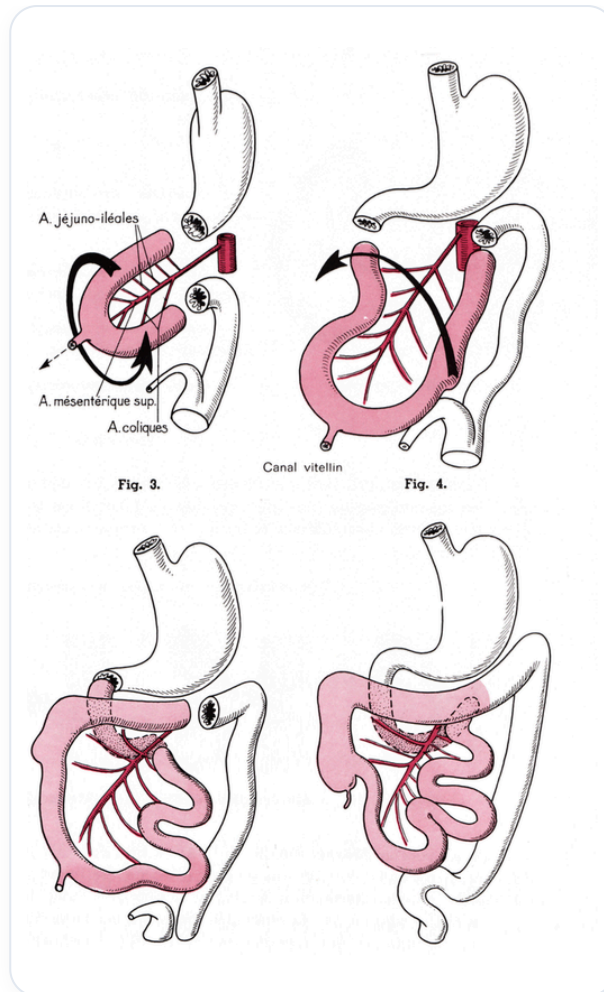


FIG. — Rotación asa intestinal

La rotación del intestino se realiza en sentido **antihorario**, de adelante hacia atrás. Paralelamente, se establece un **tubo hepatogástrico** y un tubo digestivo. También se observa una estructura mesodérmica, que está envuelta en un tejido, correspondiente a la **futura tarea** a nivel umbilical, el **conducto onfalomesentérico**. Los vasos sanguíneos se desarrollan más en esta región.

Se constata una **sincronicidad** entre el estómago y la rotación del intestino. Cuando el estómago se posiciona hacia la izquierda, el hígado se desplaza hacia la derecha. Este movimiento también provoca el posicionamiento del corazón a la izquierda, causando una congestión esplénica. El **colon** comienza a hincharse, y la arteria mesentérica superior se convierte en el punto de apoyo fundamental para el desarrollo intestinal.

A nivel vertebral, la arteria mesentérica superior corresponde al eje de **D12-L1**, que está relacionado con las zonas de inserción de los pilares diafragmáticos. Este punto de apoyo es esencial para el cuerpo e influye en la dinámica de crecimiento del intestino.

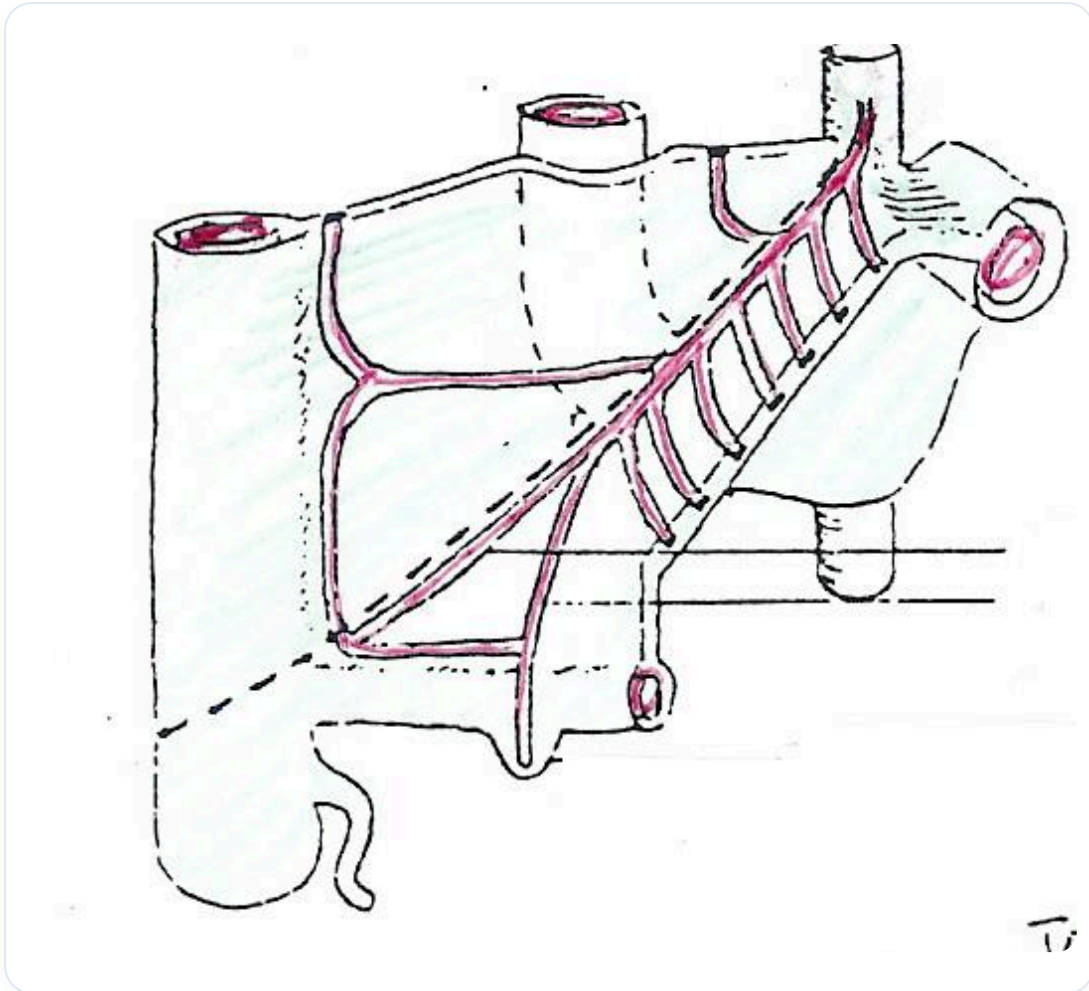


FIG. — Troncos arteriales embrionarios

El crecimiento del intestino se caracteriza por **velocidades diferenciales** ligadas a polaridades. Una mayor concentración metabólica se desarrolla hacia arriba, mientras que la parte inferior crece menos rápidamente, formando así el esbozo del **ángulo cólico izquierdo**. Este movimiento de crecimiento y rotación es crucial para la formación del intestino.

Observando la dinámica del intestino, se pueden identificar varios puntos de apoyo importantes: la arteria mesentérica, el ángulo cólico izquierdo y el marco duodenal. Estos puntos de apoyo son esenciales para el desarrollo y la función del intestino.

El **conducto onfalomesentérico**, que es el eje de rotación, termina en un vestigio llamado **divertículo de Meckel**, situado entre el eje púbico y el ciego. El desarrollo del cerebro también depende del sistema vascular digestivo. Si el aporte trófico es insuficiente, esto puede provocar complicaciones.

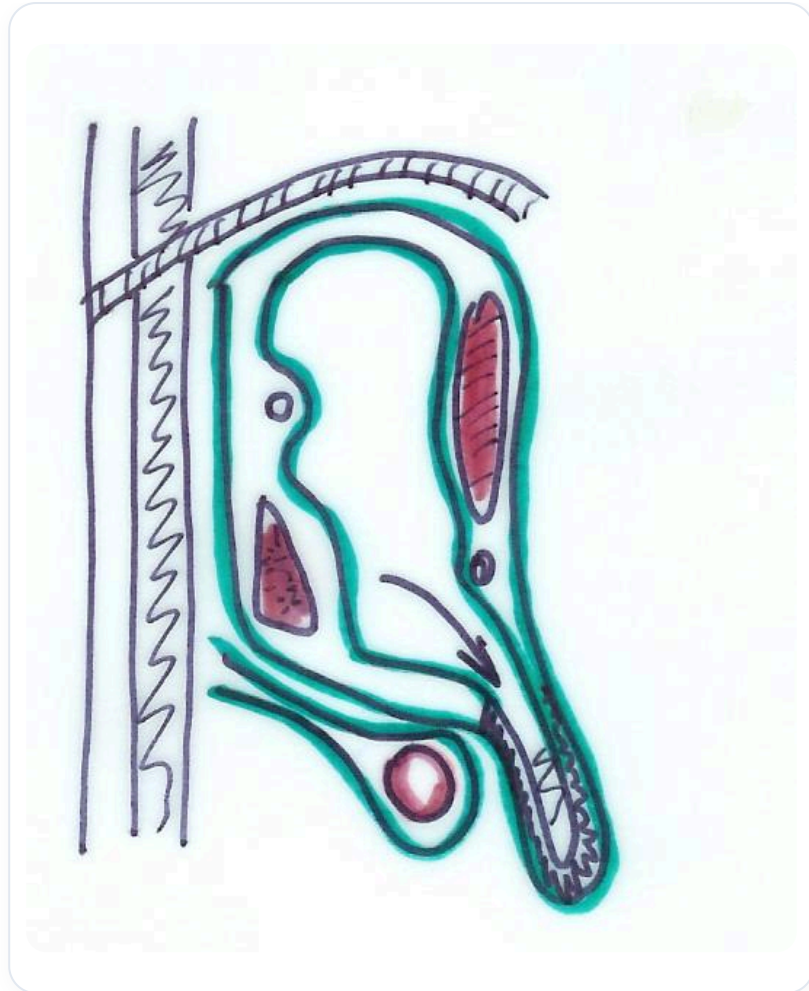


FIG. — Circulación vellosidades intestinales

La reintegración del intestino se produce durante el desarrollo, especialmente alrededor del tercer mes de embarazo, cuando el cordón umbilical comienza a formarse. Este proceso es crucial para establecer las conexiones con la madre, especialmente a través de la **cavidad amniótica**, que permite intercambios electrolíticos y hormonales.

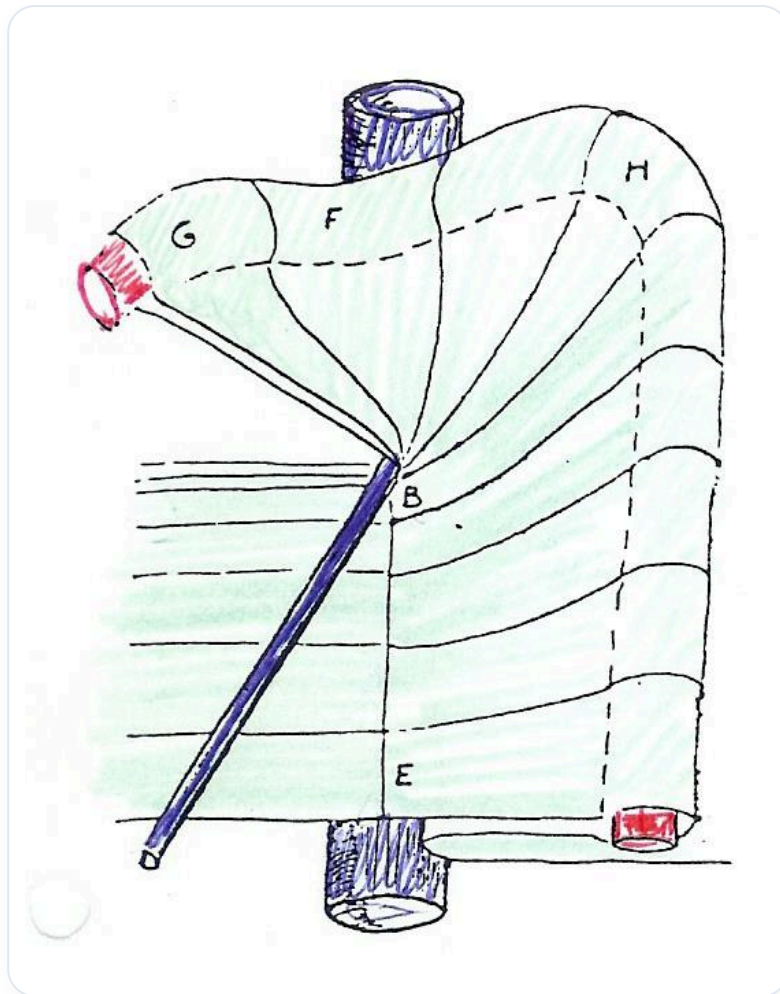


FIG. — Pliegue ventral/lateral embrionario

Las emociones y los estados de ánimo también están relacionados con la salud intestinal. El **colon ascendente** se asocia con las injusticias alimentarias, mientras que el **colon transverso** representa los humores del alma. Emociones como la ira y el miedo pueden influir en la salud digestiva.

El **colon descendente** está relacionado con problemas familiares y la búsqueda de independencia. El **apéndice** y el **ciego** desempeñan un papel importante en la defensa inmunitaria. Los problemas intestinales en los niños, como las **apendicitis**, pueden estar relacionados con fases del desarrollo embrionario.

El tratamiento de los trastornos intestinales debe tener en cuenta la dinámica peritoneal y las relaciones entre los diferentes órganos. La estabilización del marco peritoneal puede ayudar a resolver muchos problemas de salud, incluidas las infecciones y las inflamaciones.

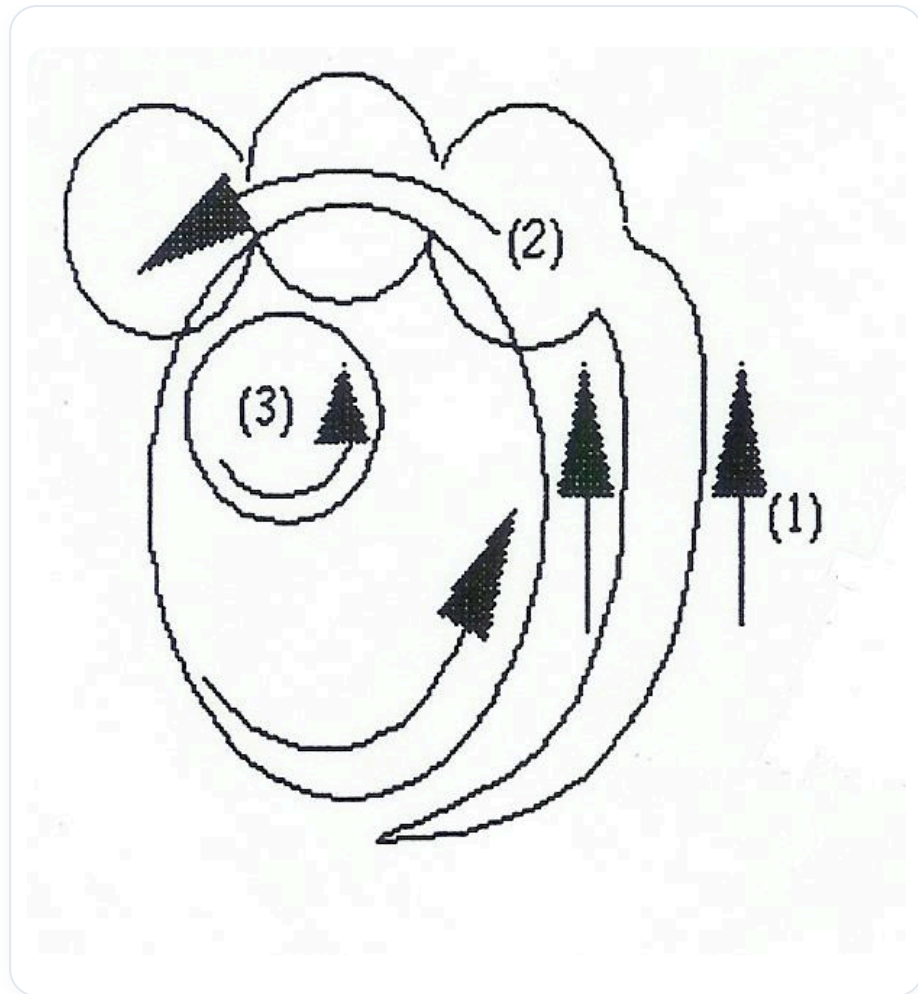


FIG. — Torbellino embriológico

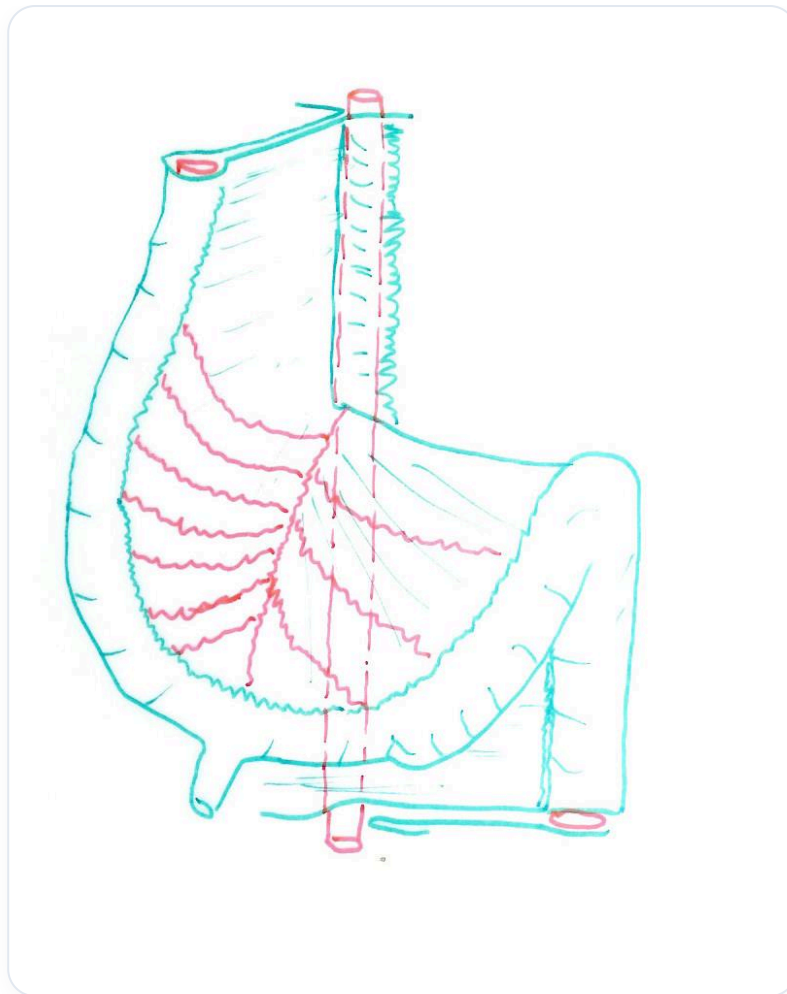


FIG. — Aparato digestivo embrionario

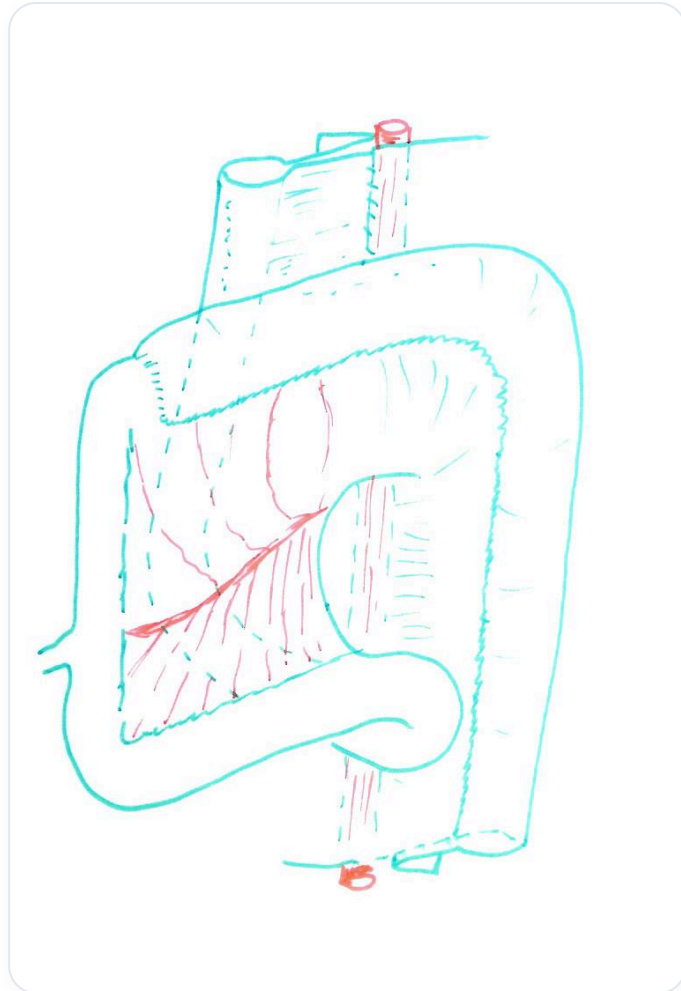


FIG. — Intestino medio, rotación

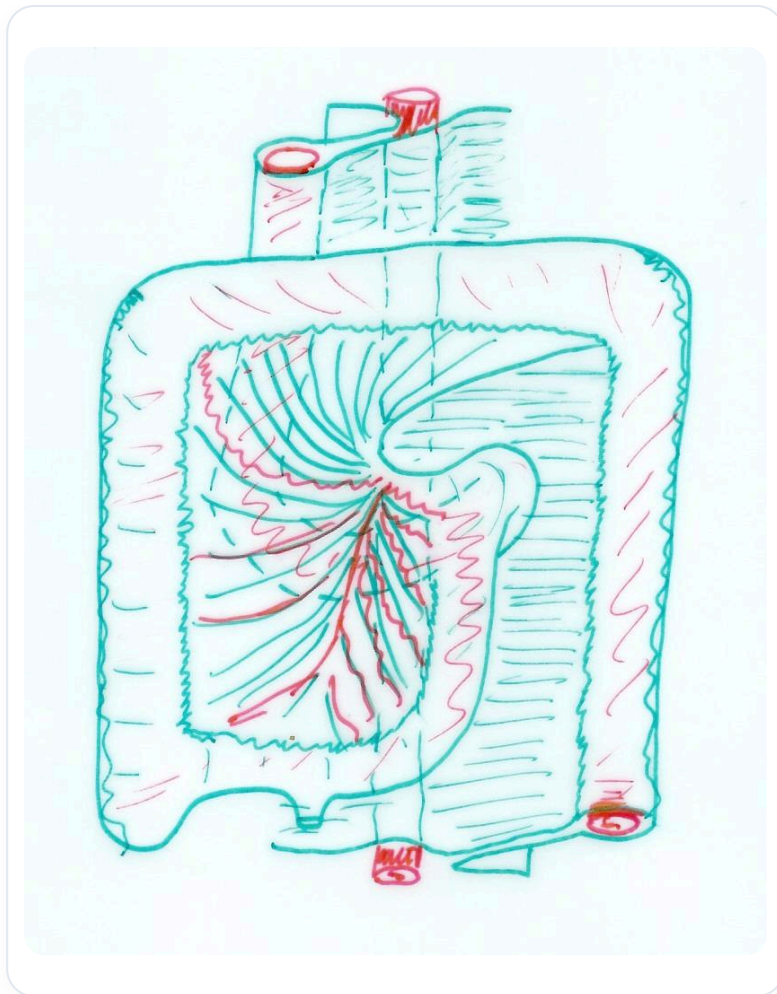


FIG. — *Intestino delgado vascularizado*

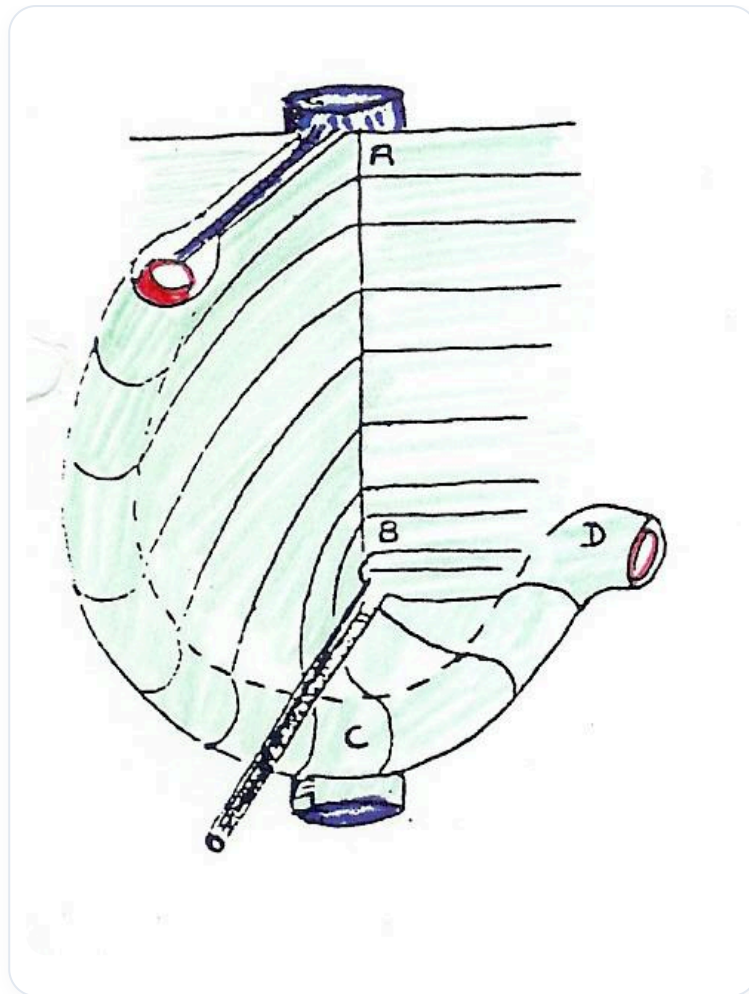


FIG. — Amniocentesis, Embrión, Útero

Appendice vermiforme (A-C2). L'appendice prend naissance de l'*extrémité postéro-médiale du caecum*. Sa situation est très variable (**D**) : dans environ 65 p. 100 des cas, l'appendice est refoulé vers le haut derrière le caecum (*situation rétrocaecale haute*) ; dans 31 p. 100 des cas, elle dépasse la linea terminalis dans le petit bassin (*situation basse*) ; dans plus de 2 p. 100 des cas, il est horizontal derrière le caecum (*situation rétrocaecale transversale*) ; chez 1 p. 100 des hommes, il est refoulé vers le haut, en avant de l'iléon (*situation paracaecale, pré-iléale montante*) ; chez environ 0,5 p. 100, il est ascendant derrière l'iléon (*situation paracaecale, rétro-iléale montante*). Dans la **position la plus fréquente (rétrocaecale haute)**, la base de l'appendice vermiforme se projette sur la paroi abdominale antérieure, au **point de McBurney (E)**. Il se situe à la jonction entre le tiers externe et le tiers moyen d'une ligne tendue entre l'épine iliaque antéro-supérieure et l'ombilic. L'appendice fait en moyenne 10 cm de long et 6 mm d'épaisseur. Les trois ténias du caecum (**C**) partent en étoile de la base de l'appendice, dans la paroi duquel ils forment une *couche musculuse longitudinale fermée*.

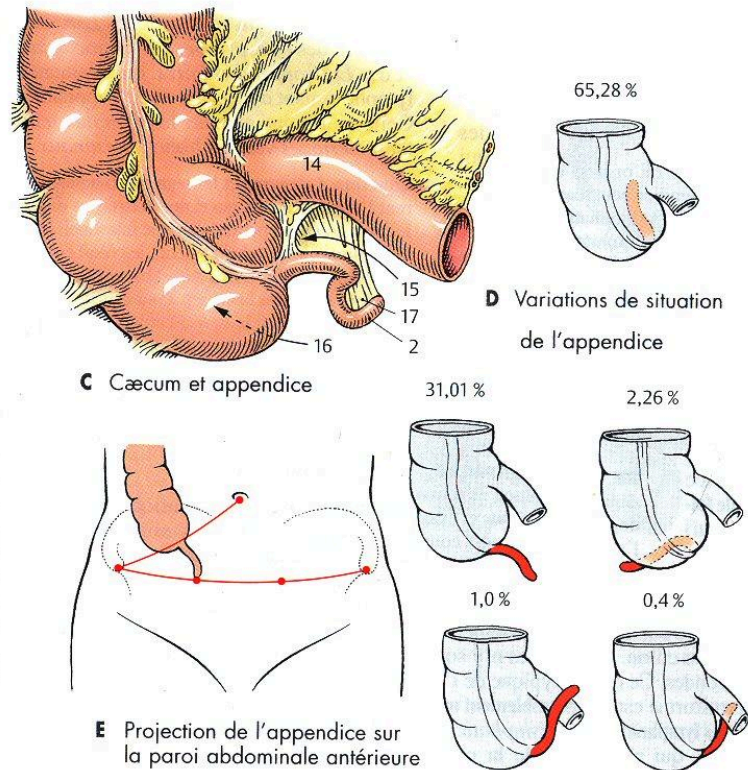


FIG. — Apéndice, ciego, variaciones

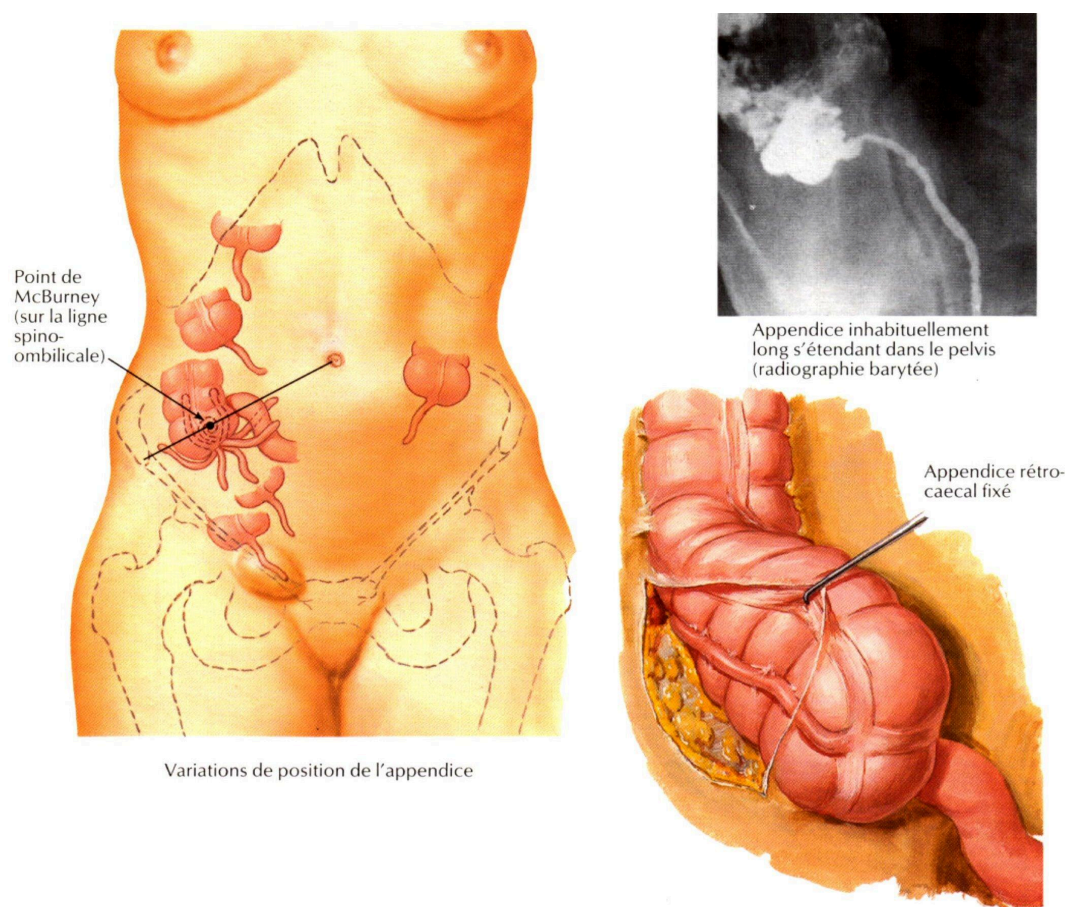


FIG. — Posición del apéndice

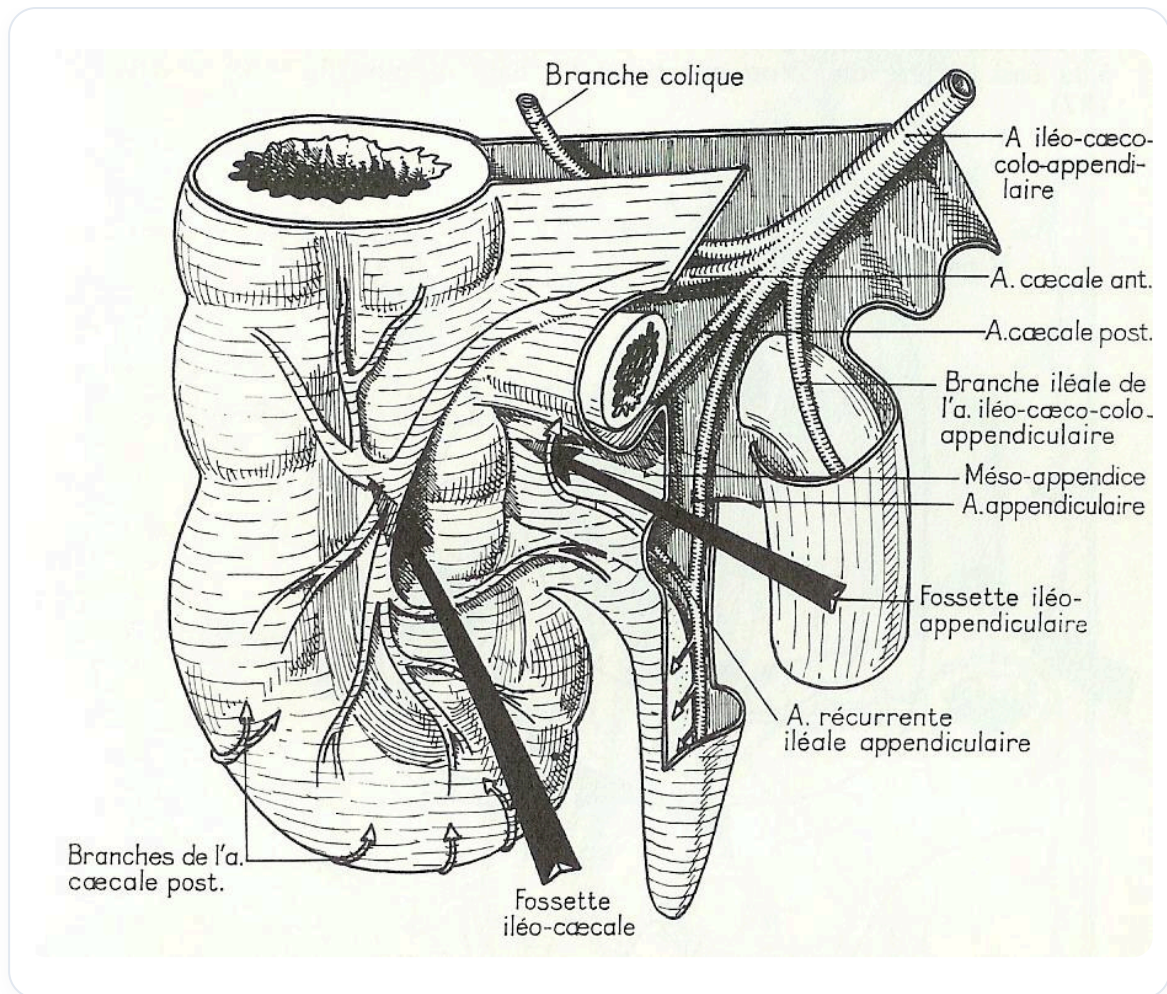


FIG. — Vascularización apéndice ciego